

33. DER WEIBLICHE GENITALAPPARAT

DAUER : 06:15

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

In diesem Video untersuchen wir ausführlich die Entwicklung des weiblichen Genitalsystems, beginnend mit der Bildung der Wolffschen und Müllerschen Gänge und deren Auswirkungen auf die reproduktive Struktur. Der Schwerpunkt liegt auf der uro-genitalen Beziehung, die sich zwischen Männern und Frauen unterscheidet, wobei die Entstehung der Gebärmutter und der Eileiter beleuchtet wird. Wir gehen auch auf die Rolle des breiten und ovariellen Bandes sowie auf die Bedeutung der Nierengesundheit für die Hormonregulation und Fruchtbarkeit ein. Das Video behandelt die fasziale Kontinuität im Becken und wie Anomalien wie Myome die gesamte Körperdynamik beeinflussen können, was entscheidende Informationen für Praktiker in der Osteopathie und Embryonalentwicklung liefert.

DER WEIBLICHE GENITALAPPARAT

1. DUCTUS MESONEPHROTICUS (WOLFF-GANG) UND PARAMESONEPHROTICUS (MÜLLER-GANG)

Der **Wolff-Gang**, auch **Ductus mesonephroticus** genannt, ist der erste Gang, der beim Embryo auftritt.

Beim Mann steigt dieser Gang ab und wird zwischen den Hoden integriert, um den **Ductus ejaculatorius** zu bilden. Der Müller-Gang bleibt hingegen als Rest bestehen und trägt zur Bildung des Prostatakerns bei.

Bei der Frau ist die Situation umgekehrt:

- Der Wolff-Gang differenziert sich zu den **Gardner-Organen**, die Rudimente sind.
- Der Müller-Gang verschmilzt und bildet die **Gebärmutter** und die **Eileiter**.

UROGENITALE ENTWICKLUNG

Die **urogenitale** Beziehung ist fundamental. Beim Mann bilden sich der Nebenhodengang, der Samenleiter und der Ductus ejaculatorius aus dieser Beziehung.

Bei der Frau findet diese Entwicklung nicht auf die gleiche Weise statt. Der Müller-Gang vereinigt sich zur Mittellinie, um die Gebärmutter zu bilden.

Die Gardner-Organen stellen die Reste des Wolff-Ganges bei der Frau dar. Der Ductus ejaculatorius ist zur Basis hin ausgerichtet, und je weiter man sich entfernt, desto mehr bildet er die Gebärmutter. Je weniger man sich entfernt, desto mehr wird das Rudiment der **Utriculus prostaticus** sein.

2. DAS BREITE BAND UND DIE EIERSTOCKBÄNDER

Bei Mann und Frau konzentriert sich das **hintere parietale Peritoneum**, um das **breite Band** sowie die kleinen Eierstockbänder und die runden Bänder zu bilden.

Es ist dasselbe Gewebe, aber mit unterschiedlichen Konzentrationen. Dieses hintere parietale Peritoneum bildet bei der Frau die Gebärmutter.

Beim Mann existiert diese Bewegung nicht, und es bleibt nur eine Konzentration des Peritoneums.

3. NIERE UND NEBENNIERE

Die Niere befindet sich unterhalb der **Nebennieren**, getrennt durch eine Kapsel. Das bedeutet, dass eine **Nierenptose** keine Nebennierenptose nach sich zieht.

Sie sind durch eine Faszia, die **Glisson-Kapsel**, getrennt. Die Niere benötigt einen Fettraum.

Bei sehr schlanken Frauen kann eine Nierenptose zu Menstruationsunregelmäßigkeiten und einer verminderten Fruchtbarkeit führen. Eine **Niere zu redynamisieren**, bedeutet auch, ihre Fruchtbarkeit zu redynamisieren.

EMBRYONALE ENTWICKLUNG DER NIERE

Anfangs, bei einem kleinen Embryo, sind die Nieren riesig, ebenso wie die Leber. Dies erinnert an die Entwicklung des Gehirns, das im Vergleich zum Rumpf anfangs sehr entwickelt ist.

Diese Proportionen entwickeln sich im Laufe der Entwicklung. Die Leber spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Nebennieren.

Dies ist das erste Mal, dass eine **strukturelle Differenzierung** zwischen Mann und Frau beobachtet wird, die mit der stärkeren Entwicklung der Drüsen zusammenhängt, die den **Müller-Hügel** bilden.

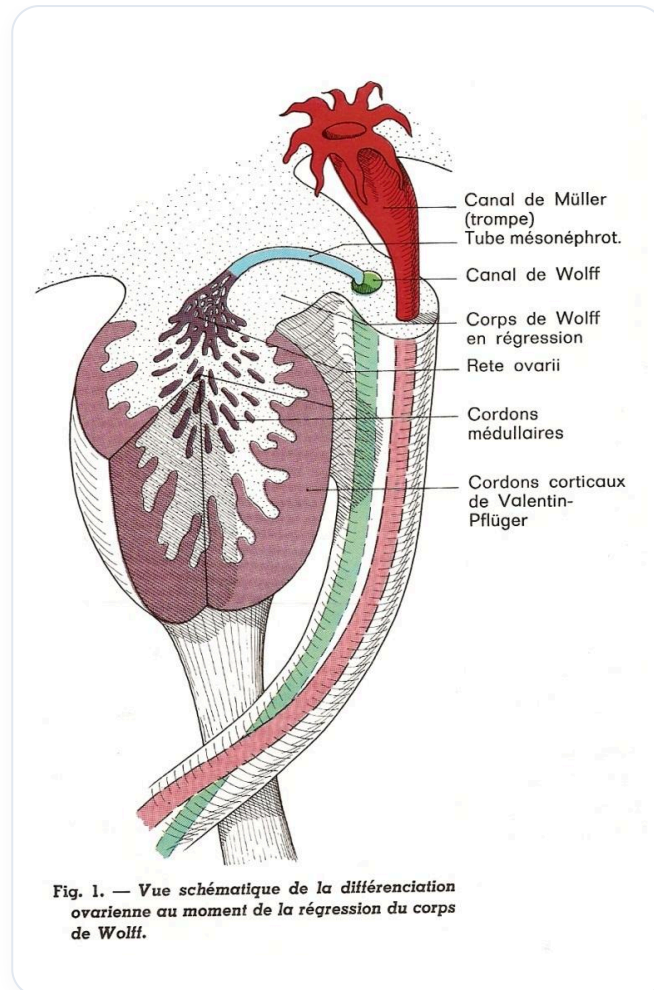


ABB. — Ovarielle Differenzierung

4. ENTWICKLUNG DES MÜLLER-SYSTEMS (5. WOCHE)

In der fünften Woche beginnt sich das System unter der Seite zu entwickeln, wodurch die Niere ihre volle Kraft zurückerhält.

Das Gehirn beeinflusst die Anlage des Herzens, das wiederum die **Diaphragmatisierung**, die Leber, die Nebennieren, die Gonaden und den Kamm anlegt.

Der Müller-Gang entwickelt sich bei der Frau viel stärker, um einen reinen Gang zu bilden, der sich zur Gebärmutter vereinigt.

Vers la 8^e semaine, le segment inférieur du **canal de Müller**, au-dessous du croisement avec le ligament inguinal, fusionne avec son homologue opposé pour former le canal utéro-vaginal, impair et médian. Cette fusion commence en bas et progresse jusqu'à la future corne utérine. La cloison médiane disparaît à la fin du 3^e mois.

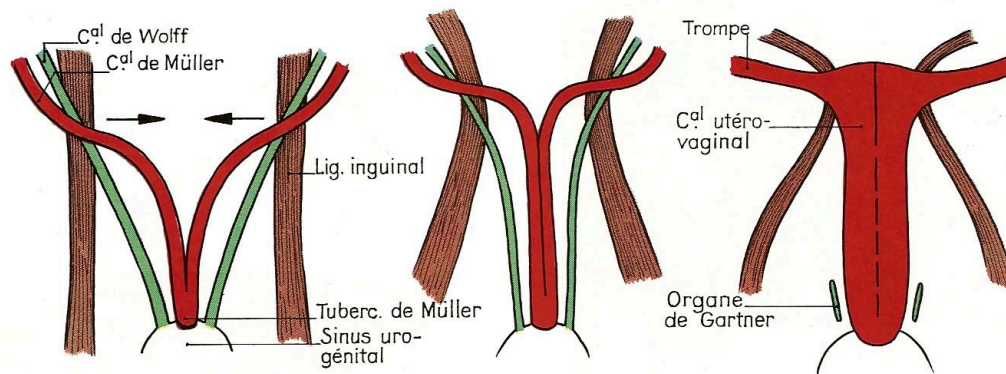


Fig. 1. — Formation de l'utérus.

ABB. — Embryonale Gebärmutterbildung

Beim Mann ist die Entwicklung weniger ausgeprägt, und das, was am unteren Ende des Müller-Ganges verbleibt, bildet den Prostatakern.

HODENABSTIEG

Der **Hodenabstieg** ist auf die differenzierte Wachstumsgeschwindigkeit im Bereich des **Gubernaculums** zurückzuführen, das verlangsamt und das gesamte System zieht.

Diese fasziale Kontinuität zwischen der Gebärmutter und dem gesamten Faszien-, Haut- und kleinen Beckenbereich ist essentiell.

5. FASCIALE KONTINUITÄT UND EINFLUSS VON STRUKTUREN

Man sieht deutlich die Gebärmutter, die Bänder, die Eierstöcke und die **Peritonealhöhle**.

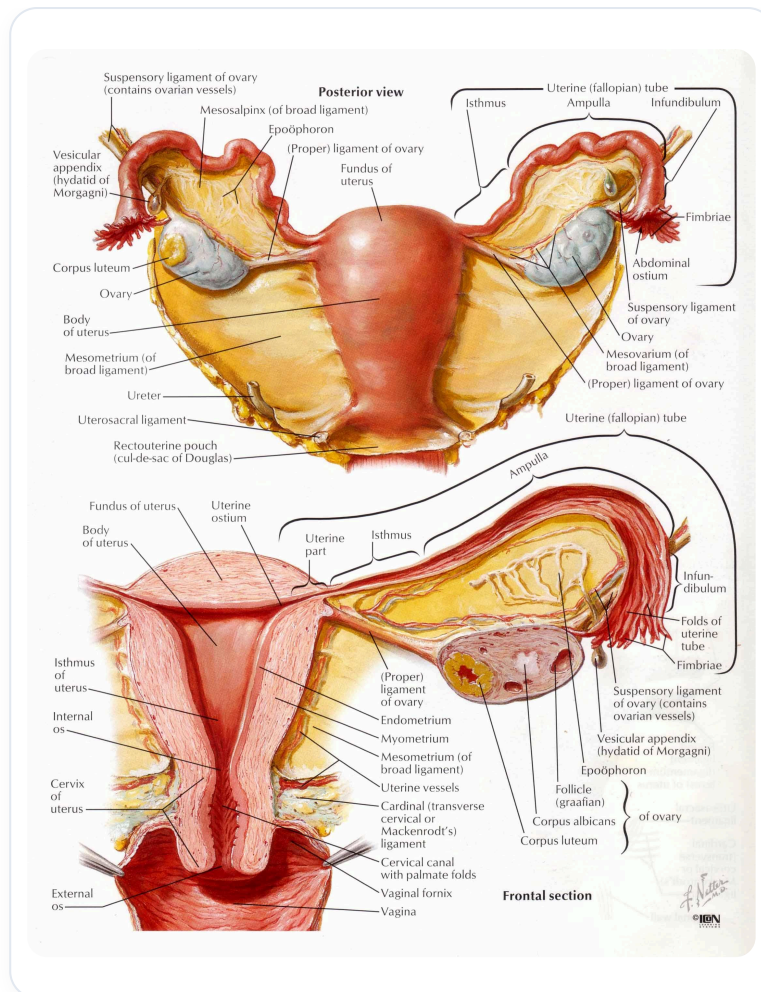


ABB. — Weiblicher Fortpflanzungstrakt

Wenn man die Gebärmutter mit Zangen anhebt, stellt man fest, dass sich alles bewegt.

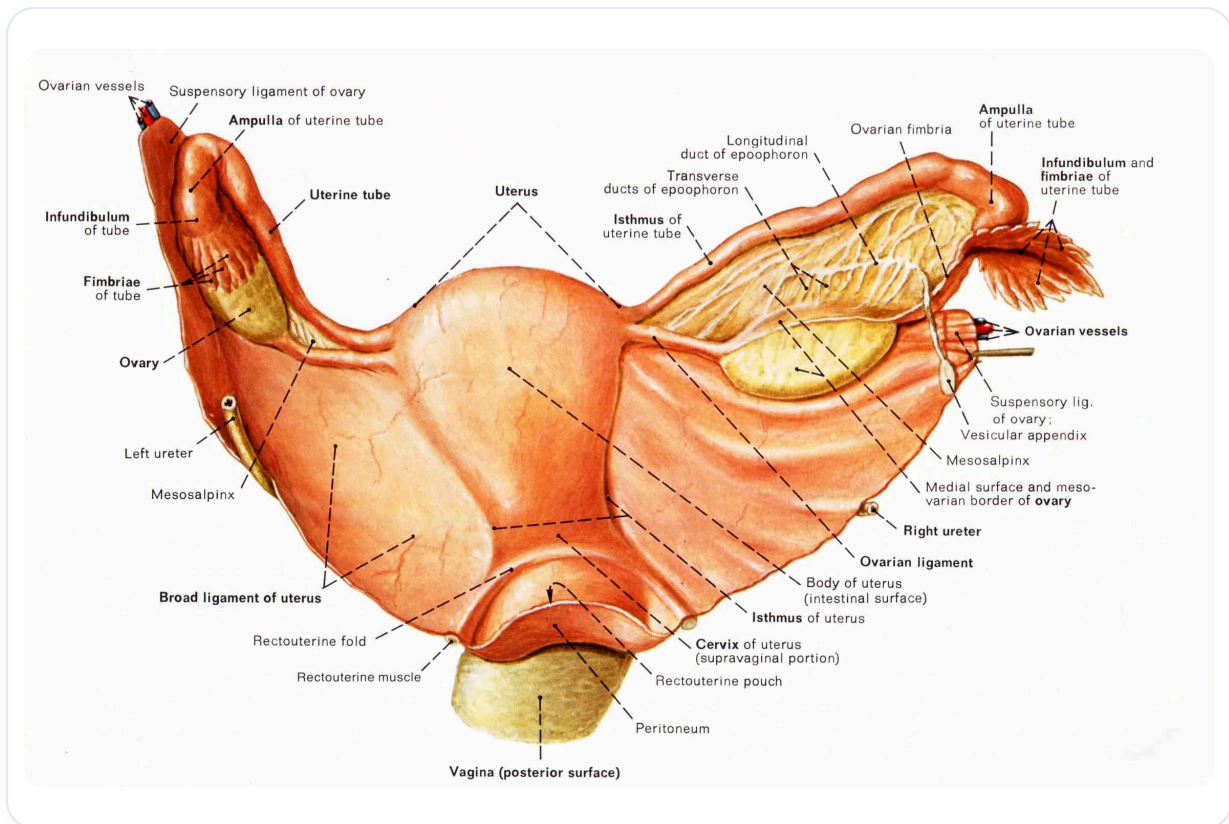


ABB. — Weiblicher Fortpflanzungstrakt

Der Einfluss eines **Myoms** oder einer **Zyste** ist signifikant. Die Kontinuität mit den Bändern ist von größter Bedeutung.

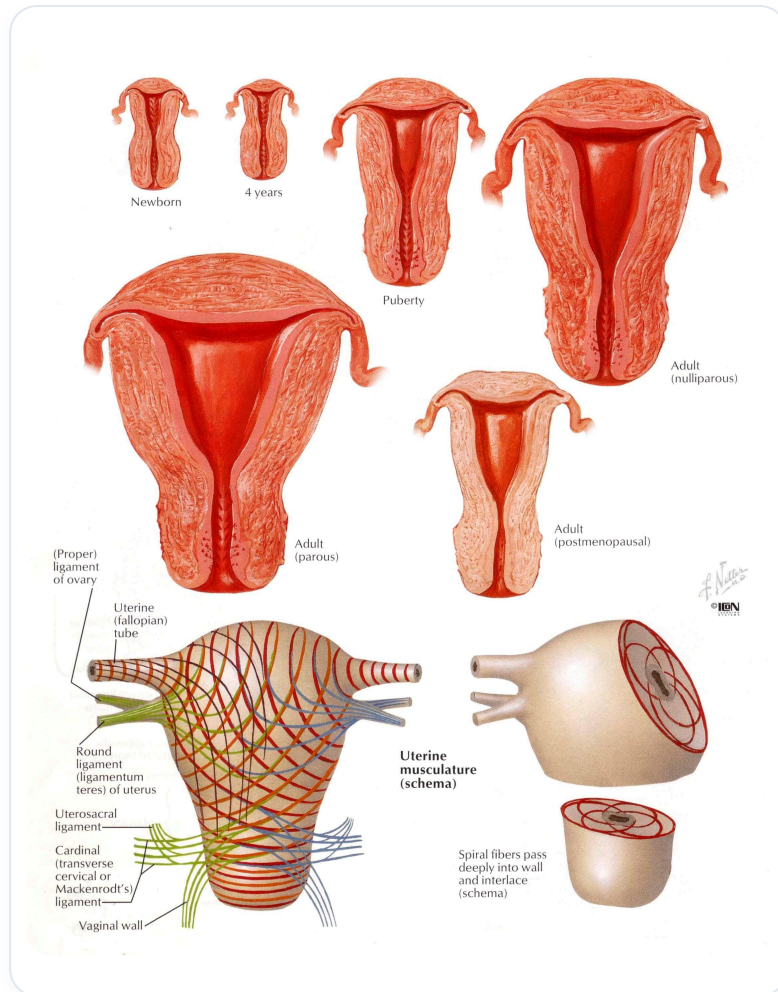


ABB. — *Gebärmutter und Muskulatur*

Wenn man stärker zieht, kann man sehen, wie das gesamte System reagiert, einschließlich der runden Bänder.

Das Peritoneum ist ein sehr intelligentes Gewebe. Der Einfluss eines Myoms beispielsweise kann das gesamte nachgeschaltete System durch eine einfache Traktion verändern.

Ein großes Myom kann eine Kaskade von Folgen im gesamten System nach sich ziehen.

ail de muer ouvert dans la cavité péritonéale devient le pectin de la trompe (organe de Rosenmüller).

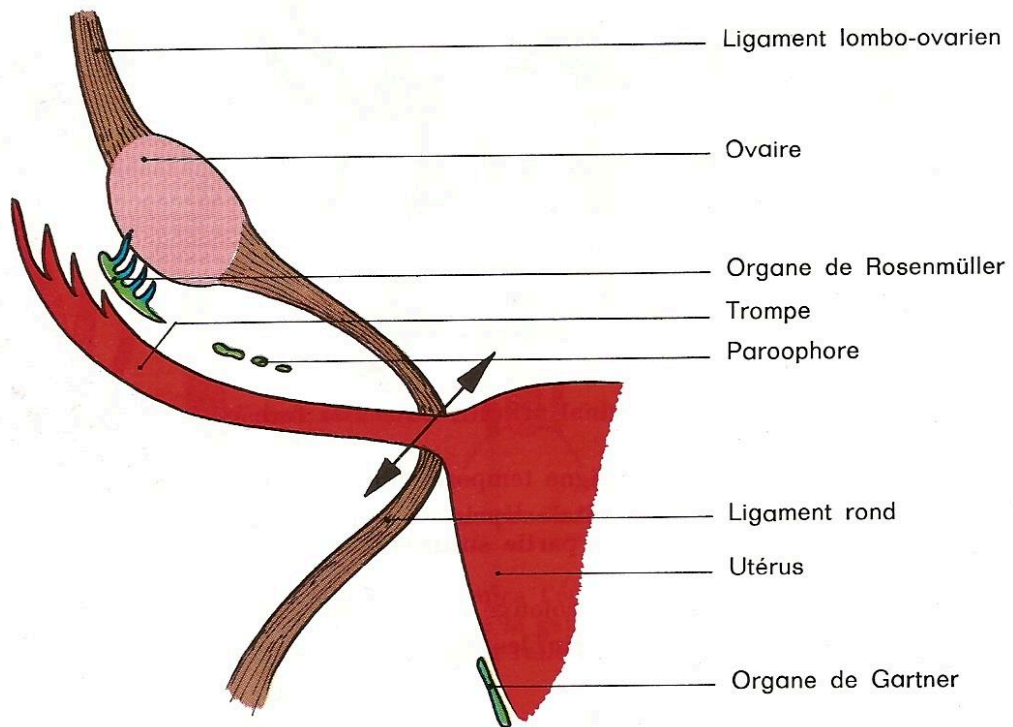
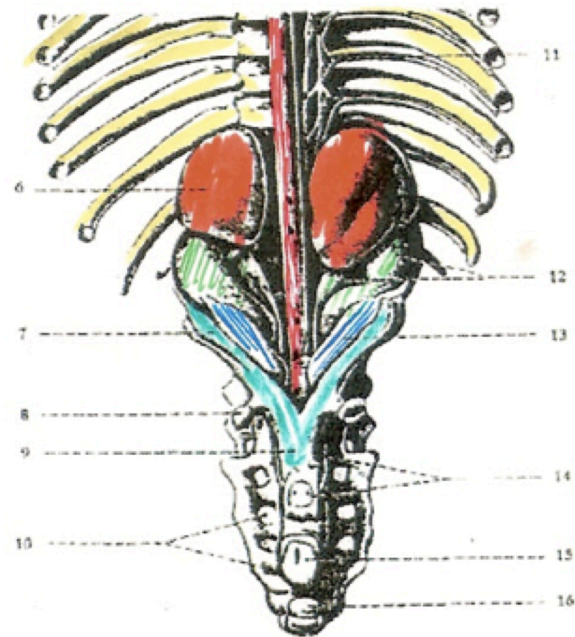


Fig. 1. — Formation de la trompe et résidus wolffiens.

ABB. — Weibliche Genitalorgane



- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 6. Glandula suprarenalis | 12. Ren, Pelvis renalis |
| 7. Müllerian duct | 13. Ovarium |
| 8. Lig.teres uteri | 14. Urether |
| 9. Uterus | 15. Anus |
| 10. For.sacralia ant. | 16. Anlage Os coccygis |
| 11. Ramus communicans | |

ABB. — Fötales Genitalsystem

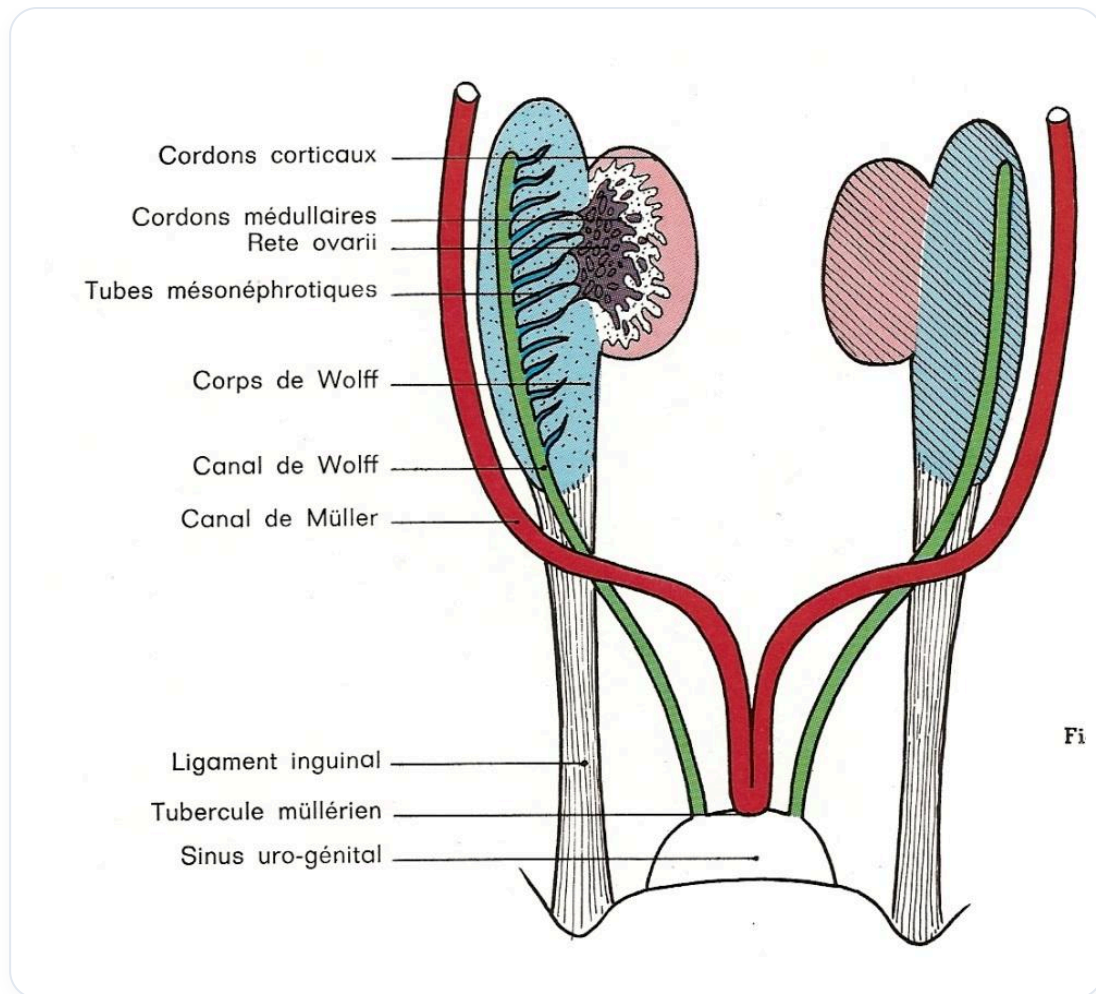


ABB. — *Undifferenziertes Genitalsystem*